Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Thomás Alejandro Pizarro Améstica				Sexo	F	M X
Fecha Nacimiento	16-01-2022	Edad actual	4 años	2 meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	Los Tamarindos V. Valle del Real				Teléfono	990574399	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☐ habla ☒ lee ☒ escribe ☐				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☐ habla ☒ lee ☒ escribe ☐				
Escolaridad actual:	Pre-Kinder B.	Establecimiento	Liceo Mixto Básica N°2.				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 16/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Thiare Anéstica Berrios	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista: 16/03/2026	4. Fecha de la entrevista:
Nombre: Catherine Estay Murcia	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Educ. Diferencial	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista:	2. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Ingreso al Programa de Integración Escolar 2026.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☐ Sí (especificar)	
Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología: TEA.	Otro:

5.1. Primer año de vida		
Tipo de parto: ☐ normal ☒ inducido ☐ fórceps ☐ cesárea (señalar motivo)		
Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO	Peso: 3.653 kg.	Talla: 54 cms.
Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:		

Todo el embarazo de alto riesgo por arteria del utero colapsada y principio preclamcia.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	No	Traumatismos	Sí	No	Encefalitis	Sí	No
Obesidad	Sí	No	Intoxicación	Sí	No	Meningitis	Sí	No
Fiebre alta	Sí	No	Enfermedad respiratoria	Sí	No	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	No	Asma	Sí	No			
Hospitalizaciones	Sí	No	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	Sí	No		Vacunas	Sí / No

Observaciones:

Traumatismo por caida de la cama.
Fiebres altas por enfermedades respiratorias.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 8 meses	Se sienta sólo/a: 8 meses	Camina sin apoyo: 1a, 7 meses.
Primeras palabras: 6 meses	Primeras frases: 1 año	Se viste solo/a: 3 años

Controla esfínter vesical Diurno: 2 a Nocturno: 3 a	Controla esfínter anal Diurno: 2 a Nocturno: 3 años

Observaciones:

Manejaba los números antes de hablar.

En su actividad motora general se aprecia: ☒ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo	**Su tono muscular general se aprecia:** ☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	Sí	No	Caídas frecuentes	Sí	No	Dominancia lateral	Sí	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	Sí	No	Prensión	Sí	No	Pinza	Sí	No
Ensarta	Sí	No	Dibuja	Sí	No	Escribe	Sí	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	Sí	No	Manipula y Explora objetos	Sí	No
Demanda objetos y compañía	Sí	No	Comprende prohibiciones	Sí	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	Sí	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	No

Observaciones:

Le dificulta comprender prohibiciones.

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Thomás evidencia molestia frente a ruidos, tapandose los oidos

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☒ oral ☐ gestual ☐ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Si	No	Emite/produce frases	Si	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Si	No	Relata experiencias	Si	No
Emite palabras/produce señas	Si	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Si	No	Sigue instrucciones simples	Si	No
Identifica personas	Si	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Si	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Si	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): No.

Observaciones:

Thomás relata sin dificultad diferentes experiencias.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Si	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Si	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Si	No	Respeta normas escolares	Si	No
Opta por trabajo individual	Si	No	Muestra sentido del humor	Si	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Si	No	Pataletas frecuentes	Si	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☐ natural ☒ desmesurada	☐ natural ☒ desmesurada	☐ natural ☒ desmesurada

Observaciones:

Presenta dificultad o molestia frente a luces altas y ruidos fuertes.

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	Si	No	Trastorno motor	Si	No
Epilepsia	Si	No	Problema bronco-respiratorio	Si	No
Problemas cardiacos	Si	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Si	No
Paraplejia	Si	No	Trastorno emocional	Si	No
Pérdida auditiva	Si	No	Trastorno conductual	Si	No
Pérdida visual	Si	No	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

Alimentación: ☒ normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☐ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☐ normal ☐ tranquilo ☒ inquieto Horas que duerme: 9 Horas.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☒ despierta de buen humor

Duerme: ☒ solo ☐ acompañado
(Especifique):

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☒ alegre ☒ juguetón/bromista ☒ risueño(a) ☐ triste ☒ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)

Otro:

Observaciones:

Es muy inquieto para dormir.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Cecilia Berrios	Abuela	56	2° Medio	Dueña Casa.
2. Natalia Amestica	Tía	34	M. O.	Cocinera.
3. Maitte Molina	Prima	6	Estudiante 1ero Básico (A)	
4. Tiare Amestica	Madre.	25	F. S. C.	Asistente de Párvulo.
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Abuela Materna perdida auditiva.
Abuelo Paterno Diabetes, Hipertensión..
Primo lado Paterno Diagnóstico TEA.

Observaciones:

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4a.	Asistió a jardín infantil	Sí	~~No~~
N° de colegios en que ha estudiado	1.	Modalidad de enseñanza Regular ~~☒~~ Especial ☐ Técnica ☐:		

Motivo de los cambios: —

Ha repetido curso/s	Sí	~~No~~	Curso(s)	Motivo: —

Situación actual

Nivel/curso actual	PK° B		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	~~No~~	**Dificultad para participar**	~~Sí~~	No	**Conducta disruptiva**	Sí	~~No~~
Asiste regularmente	~~Sí~~	No	Asiste con agrado	~~Sí~~	No	Apoyo familiar en tareas	~~Sí~~	No	Amigos (as)	~~Sí~~	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?

☐ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?

☐ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?

☐ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....

Especifique el tipo de refuerzos o premios:

☐ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?

☐ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?

☐ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

☐ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

Thomás fin de semanas vive con los dos Padres, durante la semana vive con familia Materna.

Thomás al momento de presentar una desregulación es agresivo, sin control tomando à la primera persona cerca de él.

Cuando se cae responde de la misma manera (avergonzado).

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY